



Nur zur dienstlichen Verwendung

Dieser Vermerk verliert seine Gültigkeit mit der Veröffentlichung des Protokolls gemäß § 73 GOBT, spätestens jedoch nach Ablauf der jeweils nachfolgenden Wahlperiode.

Kurzprotokoll der 6. Sitzung

Ausschuss für Gesundheit

Berlin, den 10. September 2025, 09:30 Uhr
als Kombination aus Präsenzsitzung
(Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Saal 3 101) und
Zoom-Meeting.

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 11

- a) Unterrichtung durch die Bundesregierung

Federführend:
Ausschuss für Gesundheit

**Bericht des GKV-Spitzenverbandes über die
Inanspruchnahme und Entwicklung der
Versorgung mit Digitalen
Gesundheitsanwendungen 2024**

BT-Drucksache 21/110



Nur zur dienstlichen Verwendung

- b) **Fachgespräch: Digitale Gesundheits- und
Pflegeanwendungen: Bestandsaufnahme und
Perspektiven**

Selbstbefassung S-21(14)13

Tagesordnungspunkt 2

Seite 17

**Fachgespräch: Notwendige Reformen zur
Verbesserung der Versorgung von psychisch
Kranken – Vorstellung der Ergebnisse des
2. Psychiatrie-Diologs**

Selbstbefassung S-21(14)11

Tagesordnungspunkt 3

Seite 23

- a) **Bericht Bundesrechnungshof nach § 88 Absatz 2
BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages: Entwicklung der Finanzlage in der
gesetzlichen Krankenversicherung**

Selbstbefassung S-21(14)17

- b) **Bericht der Bundesregierung zum Bericht des
Bundesrechnungshofes**

Selbstbefassung S-21(14)16

Tagesordnungspunkt 4

Seite 10

Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Gutachten 2025 des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen und in der Pflege Preise
innovativer Arzneimittel in einem lernenden
Gesundheitssystem**

BT-Drucksache 21/460

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 5

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Steffi Lemke, Dr. Jan-Nicolas Gesenhues, Julia Schneider, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frühjahrsdürre und Hitzeprognosen ernst nehmen - Jetzt entschlossen handeln

BT-Drucksache 21/351

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Haushaltsausschuss

Tagesordnungspunkt 6

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Ultraschalluntersuchungen zur Altersbestimmung in Asyl- und Strafverfahren zur Praxisreife bringen

BT-Drucksache 21/772

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Tagesordnungspunkt 7

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Keine Sonderrolle für Medizinalcannabis

BT-Drucksache 21/773

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Tagesordnungspunkt 8

Seite 10

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

COVID-19-Impfschäden ernst nehmen und deren medizinische Behandlung sicherstellen

BT-Drucksache 21/774

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 9

Seite 11

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Federführend:
Ausschuss für Gesundheit

Verbesserung der Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken durch Fluorchinolon-Antibiotika und Stärkung der Hilfe für Betroffene

BT-Drucksache 21/775

Tagesordnungspunkt 10

Seite 11

Antrag der Abgeordneten Ates Gürpınar, Doris Achelwilm, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Federführend:
Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:
Finanzausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales

Leistungskürzungen und Beitragsexplosion in Gesundheit und Pflege verhindern – Jetzt gerechte Finanzierung einführen

BT-Drucksache 21/344

Tagesordnungspunkt 11

Seite 11

Gesetzentwurf Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BR 365/25)

Tagesordnungspunkt 12

Seite 11

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zu den Änderungen vom 1. Juni 2024 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 2005

Federführend:
Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BT-Drucksache 21/1508



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 13

Seite 11

Gesetzentwurf Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (BR 366/25)**

Tagesordnungspunkt 14

Seite 28

**Nachbericht zur Sitzung des Rates für Beschäfti-
gung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher-
schutz (EPSCO) (Formation Gesundheit) am
20. Juni 2025 in Luxemburg**

Selbstbefassung S-21(14)12



Nur zur dienstlichen Verwendung

Mitglieder des Ausschusses

Fraktionen	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Beek, Sascha van Borchardt, Simone Hiller, Dr. Matthias Janssen, Anne Müller, Axel Pauls, Dr. Thomas Pilsinger, Dr. Stephan Schmidt, Sebastian Seitz, Nora Streeck, Dr. Hendrik Theiss, Dr. Hans Weiss, Dr. Maria-Lena Zeulner, Emmi	Albani, Stephan Demuth, Ellen Ehm, Lars Grasse, Adrian Knoerig, Axel Ludwig, Dr. Saskia Müller, Sepp Reddig, Pascal Rupprecht, Albert Staffler, Katrin Stegemann, Albert Timmermann-Fechter, Astrid Walch, Siegfried
AfD	Baum, Dr. Christina Bloch, Joachim Dietz, Thomas Ebenberger, Tobias Hess, Nicole Schießl, Carina Sichert, Martin Weiss, Claudia Ziegler, Kay-Uwe	Bessin, Birgit Birghan, Dr. Christoph Bollmann, Gereon Fetsch, Thomas Giersch, Alexis L. Kempf, Martina Möller, Stefan Przygodda, Kerstin Schmidt, Dr. Paul
SPD	Machalet, Dr. Tanja Mieves, Matthias David Moll, Claudia Pantazis, Dr. Christos Schwartz, Stefan Seitzl, Dr. Lina Yüksel, Serdar	Ahmetovic, Adis Dittmar, Sabine Glöckner, Angelika Kersten, Dr. Franziska Peick, Jens Schmidt, Dagmar
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dahmen, Dr. Janosch Fischer, Simone Heitmann, Linda Kappert-Gonther, Dr. Kirsten Wagner, Johannes	Grau, Dr. Armin Nick, Dr. Ophelia Piechotta, Dr. Paula Rietenberg, Sylvia
Die Linke	Gürpinar, Ates Merendino, Stella Schötz, Evelyn Stange, Julia-Christina	Arndt, Dr. Michael Brückner, Maik Fey, Katrin Gebel, Kathrin



Nur zur dienstlichen Verwendung

Liste der Sachverständigen

Fachgespräch „Digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen in der Versorgung: Bestandsaufnahme und Perspektiven“ am Mittwoch, 10. September 2025

- Bundesärztekammer (BÄK)
- GKV-Spitzenverband (GKV-SV)
- Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV)
- Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
- Dr. Michaela Eikermann
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)



Nur zur dienstlichen Verwendung

Liste der Sachverständigen

Fachgespräch „Notwendige Reformen zur Verbesserung der Versorgung von psychisch Kranken – Vorstellung der Ergebnisse des 2. Psychiatrie-Dialogs“
am Mittwoch, 10. September 2025

- Thomas Buneta
Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)
- Dr. Andrea Benecke
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
- Prof. Dr. Peter Brieger
Aktion Psychisch Kranke (APK)
- Prof. Dr. med. Prof. h.c. Dipl.-Psych. Isabella Heuser-Collier
Charité – Universitätsmedizin Berlin (Absage)
- Dr. Sylvia Claus
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)
- Dr. Elke Prestin
Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beginn der Sitzung: 9:30 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD), führt aus, dass Vorlagen, die eine Abstimmung erforderten, zu Beginn der Sitzung aufgerufen würden. Dies betreffe die Tagesordnungspunkte 4 und 5 sowie 7 bis 13. Der Tagesordnungspunkt 6 werde abgesetzt, da zunächst geprüft werden solle, ob der Gesundheitsausschuss thematisch zuständig sei. Tagesordnungspunkt 14 solle auf die nächste Sitzung am 8. Oktober 2025 verschoben werden. Die Sitzungsleitung werde sie aus terminlichen Gründen gegen 10:00 Uhr kurzzeitig an ihren Stellvertreter, Abg. Dr. Pilsinger, abgeben. Sie stellt die Tagesordnung fest.

Tagesordnungspunkt 4

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Gutachten 2025 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem

BT-Drucksache 21/460

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung der Bundesregierung auf Drucksache 21/460 einvernehmlich zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Steffi Lemke, Dr. Jan-Niclas Gesenhues, Julia Schneider, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frühjahrsdürre und Hitzeprognosen ernst nehmen - Jetzt entschlossen handeln

BT-Drucksache 21/351

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, dem Plenum des Deutschen Bundestages die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/351 zu empfehlen.

Tagesordnungspunkt 6

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Ultraschalluntersuchungen zur Altersbestimmung in Asyl- und Strafverfahren zur Praxisreife bringen

BT-Drucksache 21/772

abgesetzt

Tagesordnungspunkt 7

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Keine Sonderrolle für Medizinalcannabis

BT-Drucksache 21/773

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) führt den Antrag auf Drucksache 21/773 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/773 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 8

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

COVID-19-Impfschäden ernst nehmen und deren medizinische Behandlung sicherstellen

BT-Drucksache 21/774

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) führt den Antrag auf Drucksache 21/774 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/774 durchzuführen.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 9

Antrag der Abgeordneten Martinichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Verbesserung der Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken durch Fluorchinolon-Antibiotika und Stärkung der Hilfe für Betroffene

BT-Drucksache 21/775

Abg. **Dr. Christina Baum** führt den Antrag auf Drucksache 21/775 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/775 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 10

Antrag der Abgeordneten Ates Gürpınar, Doris Aichelwilm, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Leistungskürzungen und Beitragsexplosion in Gesundheit und Pflege verhindern – Jetzt gerechte Finanzierung einführen

BT-Drucksache 21/344

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) führt den Antrag auf Drucksache 21/344 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/344 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 11

Gesetzentwurf Bundesregierung Gesetz zur Befugnisenerweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege

BT-Drucksache 21/1511

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich vorbehaltlich der Überweisung durch das Plenum, eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 21/1511 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 12

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zu den Änderungen vom 1. Juni 2024 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23. Mai 2005

BT-Drucksache 21/1508

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich vorbehaltlich der Überweisung durch das Plenum, eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 21/1508 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 13

Gesetzentwurf Bundesregierung Gesetzes zur Änderung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes

BT-Drucksache 21/1504

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich vorbehaltlich der Überweisung durch das Plenum, eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 21/1504 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 1

a) Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht des GKV-Spitzenverbandes über die Inanspruchnahme und Entwicklung der Versorgung mit Digitalen Gesundheitsanwendungen 2024

BT-Drucksache 21/110

Die **Vorsitzende** teilt mit, dass es technische Probleme gebe und die Sitzung im Saal PLH 4 600 fortgesetzt werde. Außerdem werde ihr Stellvertreter, Abg. Dr. Pilsinger, für eine kurze Zeit die Sitzungsleitung übernehmen.

9:48 Uhr Übergabe der Sitzungsleitung an den stellvertretenden Vorsitzenden Abg. Dr. Pilsinger und 9:48 Uhr bis 10:07 Uhr Unterbrechung der Sitzung

Der **stellvertretende Vorsitzende** erläutert, dass es nicht möglich gewesen sei, einen ausgehenden Ton für die Onlineteilnehmer herzustellen und bedankt



Nur zur dienstlichen Verwendung

sich für den schnellen Raumwechsel. Er gehe davon aus, dass jetzt alles fehlerfrei funktioniere.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt ein, die Digitalisierung im Gesundheitsbereich sei ein wichtiges Anliegen. Der GKV-Spitzenverband lege jährlich einen Bericht über die Entwicklung der digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) vor. Die Versorgung mit DiGA schreite progressiv voran. Zehn weitere Anwendungen seien 2024 als erstattungsfähig anerkannt worden. Es seien insgesamt 423 000 DiGA in Anspruch genommen worden, was einem Zuwachs von 85 Prozent entspreche. Das Durchschnittsalter der Nutzenden liege bei 47 Jahren, was die Annahme widerlege, dass nur jüngere Menschen diese Leistungen in Anspruch nähmen. Die Ausgaben hierfür beliefen sich auf 110 Millionen Euro. Kritisiert werde die DiGA-Einführung von der GKV lediglich im Hinblick auf die Evidenzbasierung und das Erprobungsverfahren. Diese Kritik teile das BMG nicht. Nun gebe es auch die digitale Pflegeanwendung (DiPA). Man hoffe, dass das Gesetz zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege die Entwicklung von DiGA fördern werde. Verbesserungen, insbesondere bei der Erprobung, seien vorgesehen. Die Aufhebung der Erforderlichkeitsprüfung und die Erweiterung des begünstigten Personenkreises lasse hoffen, dass dieser für die Pflege wichtige Anwendungsbereich weitere Marktdurchdringung finde. Die Errungenschaften dieser Versorgungsmöglichkeiten müssten weiterhin proaktiv in der Diskussion betont und beworben werden. Leistungserbringer sollten die Möglichkeit der Anwendung und Verordnung in ihre Überlegungen mit einbeziehen, um eine kostensparende und innovative Versorgung zu gewährleisten.

b) Fachgespräch: Digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven

Selbstbefassung S-21(14)13

Der **stellvertretende Vorsitzende** begrüßt alle Sachverständigen und entschuldigt sich für den unvorhergesehenen Raumwechsel.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) führt aus, DiGA seien seit fünf Jahren eine GKV-Leistung, zusätzlich gebe es die digitalen Pflegeanwendungen (DiPA). Er sehe in DiGA und DiPA Potenzial zur Verbesserung der Versorgung, weil sie Versicherte zur Mitgestaltung befähigten. Gleichzeitig bestehe ein erhebliches Missverhältnis gegenüber anderen GKV-Leistungen bezüglich des Nutzens und der Wirtschaftlichkeit. Die GKV müsse DiGA auch dann bezahlen, wenn sie lediglich zur Erprobung in den Leistungskatalog aufgenommen würden und sich später kein Nutzen für die Versorgung zeige. Hersteller könnten zunächst einen beliebig hohen Preis für DiGA festlegen, der bezahlt werden müsse, auch wenn er unwirtschaftlich sei. Für vier von fünf DiGA habe bei der Aufnahme in den GKV-Leistungskatalog kein Nutzen nachgewiesen werden können. Dies bleibe in den meisten Fällen über einen Zeitraum von zwei Jahren so. Auch in diesen Fällen müssten die Kassen den vom Hersteller gewählten Preis bezahlen, bevor eine Verhandlung und eine Preisanpassung im Sinne der Wirtschaftlichkeit möglich sei. Die von den Herstellern festgelegten Preise lägen im Schnitt bei 540 Euro, wohingegen die verhandelten Preise circa 220 Euro betrügen und somit 60 Prozent niedriger ausfielen. Die teuerste DiGA habe über 2 000 Euro gekostet, obwohl über zwei Jahre kein Nutzen nachgewiesen worden sei. Zum Vergleich könne ein Diabetiker für 2 000 Euro zehn Jahre leitliniengerecht ärztlich behandelt werden. Diese extremen Preisunterschiede machten deutlich, dass die von den Herstellern gewählten Preise nicht angemessen seien. Ein klarer Patientennutzen und Wirtschaftlichkeit seien elementare Grundsätze in der GKV und müssten auch für DiGA und DiPA gelten. Hersteller dürften die Preise nicht länger frei wählen, sondern müssten diese schon bei Markteintritt mit der GKV verhandeln. Zumindest sei die Phase der frei wählbaren Preise, wie im Arzneimittelbereich, auf ein halbes Jahr zu reduzieren. Verhandelte Preise müssten im Sinne einer wirtschaftlichen Versorgung so früh wie möglich greifen.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) führt aus, DiGA seien ein diagnostisches und therapeutisches Mittel mit großem, bei Weitem noch nicht ausgeschöpftem Potenzial. Er stimme vielen Punkten von Herrn Busse zu und es müsse stringenter mit der wissenschaftlichen Evidenz umgegangen werden. DiGA müssten stärker in den



Nur zur dienstlichen Verwendung

ärztlichen Behandlungsalltag integriert werden. Ein separater Behandlungsstrang durch DiGA, der durch Selbstmanagement entstehe, sei nicht hilfreich. Nur DiGA, die einen Mehrwert für die Behandlung kranker Menschen böten, sollten zugelassen werden. Er sei zwar kein Experte für die Preisfindung, sei aber der Ansicht, dass ein gewisser Grad an Evidenz bereits vor der Aufnahme in die verordnungsfähigen Leistungen vorliegen sollte. Die Ärzteschaft versuche, das Thema in der Aus-, Weiter- und Fortbildung zu implementieren. Er äußert sich kritisch zur Aufnahme der Risikoklasse 2b in das normale Zulassungsverfahren seit 2024, da diese Produkte invasiv sein könnten und einer anderen Zulassungsform bedürften.

Dr. Michaela Eikermann (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)) führt aus, die ersten DiGA seien im September 2020 verfügbar gewesen. Das Potenzial liege darin, dass DiGA zeit- und ortsunabhängig genutzt werden könnten, wodurch möglicherweise schwer erreichbare Menschen angesprochen würden. Das Fast-Track-Verfahren habe ein strukturiertes Verfahren geschaffen, um Anwendungen zu implementieren, die einen positiven Versorgungseffekt zeigten. Diesem Verfahren liege jedoch eine sehr breite Definition des medizinischen Nutzens und schwächere Anforderungen an die Evidenz zugrunde als bei anderen Verfahren. Anhand der Erfahrungen der letzten fünf Jahre gebe es Optimierungspotenzial. Ein wesentlicher Punkt sei die fehlende Transparenz des Verfahrens für die Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit. Zentrale Studienergebnisse und die Studienmethodik seien in vielen Fällen nicht öffentlich verfügbar. Eine ausführliche Darstellung der Bewertungsmethodik und der Ergebnisse des Bewertungsverfahrens des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) fehle. Auch die Bewertungsentscheidung selbst umfasse keine Aussagen zur Qualität der Studien und zur Aussagesicherheit. Dies erschwere die Einordnung möglicher Qualitätsmängel. Eine solche Einordnung sowie ein transparentes Bewertungsverfahren könnten die Akzeptanz der DiGA verbessern. Ein weiterer Punkt mit Optimierungspotenzial sei die Erprobung, da in dieser Zeit zahlreiche Patienten eine Anwendung benutzten, deren Nutzen nicht bekannt sei oder, wie sich in einigen Fällen gezeigt habe, nicht habe nachgewiesen werden können. Insgesamt seien 14 DiGA nach der

Erprobung aus dem Verzeichnis gestrichen worden. Sie regt an, zu überdenken, ob die Anforderungen an die Erprobung angehoben werden sollten oder ob es wirklich sinnvoll sei, dass DiGA innerhalb des Erprobungszeitraums allen geeigneten Versicherten zur Verfügung ständen. Mit Blick auf die neuen Regelungen zur anwendungsbegleitenden Erfolgsmessung erklärt sie, es werde schwierig sein, die unterschiedlichen Datenqualitäten zusammenzuführen. Es sei wichtig, nicht nur die Adhärenz zu betrachten, sondern die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Betroffenen.

Anisa Idris (Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV)) führt aus, dass eine Million Patienten mit DiGA versorgt worden seien. DiGA schlossen Versorgungslücken, unterstützten Therapien und machten Therapien für Menschen zugänglich, die sonst keinen Zugang hätten. Nach fünf Jahren seien 58 DiGA im Leistungsverzeichnis, davon seien 45 dauerhaft gelistet. Diese Zahlen zeigten, dass das Verfahren streng sei. Alle zugelassenen DiGA basierten auf randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) und hätten einen Nutzen gezeigt. Sie stellt klar, dass DiGA wirksame Medizinprodukte seien. Der Nutznachweis, der in der Erprobung zu erbringen sei, beziehe sich darauf, ob die DiGA besser als die bestehende Versorgung sei. DiGA seien mit 580 Millionen Behandlungsfällen in der ambulanten Versorgung immer noch eine Randerscheinung. Es werde mehr digitale Versorgung benötigt, um Krankheiten zu managen. Im Bereich der DiPA sei die Bilanz ernüchternd. Es gebe nach fünf Jahren keine einzige DiPA im Leistungsverzeichnis. Es müsse einen stabilen Rechtsrahmen geben. Seit 2020 hätten sich die Anforderungen an DiGA kontinuierlich verändert, und die Hürden würden immer höher. Dies betreffe insbesondere die gesetzlichen Anpassungen, Änderungen in der Interpretation durch das BfArM, die Gesundheits-ID und die elektronische Patientenakte, das BSI-Datensicherheitszertifikat sowie anstehende Änderungen wie das Datenschutzzertifikat. Die Bürokratie müsse abgebaut werden. Es sei nicht gut für die Nutzenden, dass DiGA noch immer auf Papierbasis verschrieben würden. Die BSI-Sicherheitsstandards hätten zu Extremsituationen bei Patientinnen und Patienten geführt. Es werde eine Regulierung benötigt, die gleiche Maßstäbe für alle kritischen Lebensbereiche setze, auch im Hinblick auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Thomas Pauls** (CDU/CSU) fragt den GKV-Spitzenverband, ob die gegenwärtige Nutzung von DiGA auf bestimmte Anwendungsfelder wie die Prävention beschränkt sei. Er möchte wissen, wie der Verband einen breiteren Einsatz von DiGA bewerte, insbesondere im Bereich der Prävention, der Vernetzung mit Drittanbieter-Apps und der Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, Präventions-DiGA seien momentan noch nicht zugelassen, aber im Koalitionsvertrag angedacht. Er verweist auf die fast 60 im Verzeichnis gelisteten DiGA. Schwerpunkte fänden sich in den Bereichen psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen, aber auch bei Stoffwechselerkrankungen sowie bei physiotherapeutischen Angeboten. Er würde es begrüßen, wenn diese Angebote sich noch besser in die bestehenden Versorgungsstrukturen integrierten.

Abg. **Dr. Thomas Pauls** (CDU/CSU) fragt nach den Gründen dafür, dass rund ein Fünftel der verordneten DiGA nicht aktiviert und genutzt werde. Er möchte wissen, welche Maßnahmen unternommen werden könnten, um die Anwendung zu verbessern.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, die Beobachtung beziehe sich darauf, dass zum Stichtag des Berichts 80 Prozent der Verordnungen eingelöst worden seien. Es könne einen Zeitversatz geben. Dies müsse nicht bedeuten, dass 20 Prozent der Verordnungen nicht eingelöst worden seien. Zum Stichtag könne die genaue Zahl nicht beziffert werden.

Abg. **Dr. Thomas Pauls** (CDU/CSU) fragt, ob dennoch Hindernisse gesehen würden und was unternommen werden müsse, um die Situation zu verbessern. Er verweist dabei auf die papierbasierte Verschreibung und möchte wissen, ob es einen besseren Weg gebe, eine DiGA direkter an die Patienten zu bringen.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, er stimme Frau Idris zu, dass die Prozesse so digital wie möglich gestaltet werden müssten. Er halte es

jedoch für essenziell, dass die medizinische Notwendigkeit festgestellt werde, auch wenn die Verordnung über eine Videosprechstunde erfolge. Es müsse genau darauf geachtet werden, dass ärztlich festgestellt werde, ob die Behandlungsform der DiGA tatsächlich benötigt werde.

Abg. **Dr. Thomas Pauls** (CDU/CSU) fragt, welche Gründe es dafür gebe, dass es noch keine DiPA im Leistungsverzeichnis gebe und wie sich das Gesetz zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege hier auswirken werde.

Wibke Wüstenhöfer-Eck (GKV-Spitzenverband) antwortet, der Verband sei nicht in das Zulassungsverfahren für DiPA eingebunden. Da die Prüfung der Anträge ausschließlich durch das BfArM erfolge, könne er keine validen Aussagen zu den Gründen für Rücknahmen oder Ablehnungen machen. Das Gesetz zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege könne sich in manchen Punkten positiv auswirken. Positiv sei, dass der Zeitpunkt der Anspruchsentstehung und die Verhandlung des Vergütungspreises parallelisiert würden, was für Sicherheit Sorge. Auch sei die Zulassung von DiPA für Pflegende und Angehörige, die nicht strikt an die Kriterien zur Pflegebedürftigkeit geknüpft sei, sinnvoll, da DiPA die häusliche Versorgung stabilisieren könnten. Dagegen werde das Erprobungsjahr sehr kritisch gesehen und abgelehnt. Wie bei den DiGA bestehe die Gefahr, dass Pflegebedürftige für bis zu zwei Jahre mit DiPA ohne nachgewiesenen Nutzen versorgt würden. Dies führe nicht zu einer Etablierung von DiPA.

Abg. **Tobias Ebenberger** (AfD) führt aus, die Anforderungen im Zulassungsverfahren seien im Vergleich zu anderen Leistungen niedriger, da teilweise eine alleinige Verfahrensverbesserung ohne medizinischen Nutznachweis genüge. Er fragt Herrn Busse, was mit den vier von fünf Anwendungen geschehe, die keinen Nutznachweis hätten.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, diese Aussage beziehe sich auf den Status bei Aufnahme in den Leistungskatalog, wobei eine Erprobung über zwei Jahre erfolge. In dieser Zeit müssten die Krankenkassen die von den Herstellern festgelegten Preise bezahlen, bevor Verhandlungen



Nur zur dienstlichen Verwendung

über einen Vergütungsbetrag stattfinden könnten. Werde eine DiGA ganz oder würden Teile gestrichen, müsse über Ausgleichsansprüche verhandelt werden. Bei gestrichenen DiGA sei es nun etabliert, den Preis ab dem 13. Monat auf 0 Euro zu setzen, da kein Nutzen nachgewiesen worden sei. Die im ersten Jahr gezahlten Beitragsgelder seien jedoch weg, was er als Wirtschaftsförderung bezeichne. Er führt aus, dass von 47 abgeschlossenen Erprobungsverfahren 15 vollständig gestrichen und bei sieben Teilstreichungen vorgenommen worden seien.

Abg. **Tobias Ebenberger** (AfD) fragt, was der Sachverständige vorschläge, um den Erprobungszeitraum zu verbessern oder zu verkürzen. Er möchte wissen, was ein idealer Zeitraum wäre.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, der GKV-Spitzenverband habe oft die Position vertreten, dass verhandelte Preise idealerweise ab der Aufnahme in den Leistungskatalog gelten sollten. Er verweise auf den Arzneimittelbereich, in dem die Phase der freien Preise auf ein halbes Jahr reduziert worden sei. Solle am Erprobungsmodell festgehalten werden, sei ein gesetzgeberisches Korrektiv erforderlich. Er schlägt vor, nach Überschreiten des ersten Jahres den Preis automatisch auf das Niveau der verhandelten Preise abzusenken. Dies verhindere, dass Beitragsgelder verloren gingen und Hersteller bei hohen Verordnungsmengen am Ende der Erprobungszeit nicht in der Lage seien, Ausgleichsansprüche zurückzuzahlen. Dieser Ansatz sei eine mögliche Lösung, die zumindest ab dem 13. Monat greifen könnte.

Abg. **Tobias Ebenberger** (AfD) fragt Dr. Michaela Eikermann, wie in Zukunft sichergestellt werden solle, dass DiGA-Studien methodisch valide seien. Er merkt an, dass viele Studien nicht verblindet seien und Endpunkte oft selbstberichtete Vorteile seien, weshalb das Verzerrungspotenzial hoch sei. Er möchte wissen, ob systematisch eine Verblindung oder die Nutzung externer Endpunkte eingefordert werde.

Dr. Michaela Eikermann (Institut für Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)) antwortet, Letzteres sei sicherlich

sinnvoll. Es gebe oft selbstberichtete und fremdbberichtete Instrumente. Das Problem der fehlenden Verblindung sei dann zwar nicht vollständig behoben, aber geringer, da die Person, die den Endpunkt erhebe, nicht wisse, ob die DiGA verabreicht worden sei. Die Studienqualität könne so verbessert werden. Grundsätzlich sei eine verblindete Durchführung von DiGA-Studien möglich, aber nicht in jeder Form und an allen Stellen umsetzbar. Zudem sei es zum Teil ein eher theoretisches Konstrukt, eine DiGA und eine Scheinanwendung zu entwickeln.

Abg. **Tobias Ebenberger** (AfD) fragt den GKV-Spitzenverband, wie man gesetzgeberisch vorgehen oder lösen könne, dass ausgezahlte Gelder bei fehlendem Nutznachweis wieder eingezogen werden könnten, damit es sich nicht um eine Wirtschaftsförderung, sondern um einen sinnvollen Einsatz der Mittel handle.

Der **stellvertretende Vorsitzende** informiert darüber, dass die Fragezeit der Fraktion der AfD abgelaufen sei.

Abg. **Matthias Mieves** (SPD) fragt nach Potenzialen für mehr Transparenz im Zulassungsverfahren und wie diese mit der Personalsituation beim BfArM zusammenhängen. Er führt aus, dass es bei der Zulassung oft zu Verzögerungen und Intransparenz komme.

Anisa Idris (Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV)) antwortet, dass in der Regel die Wartezeit für einen Beratungstermin beim BfArM neun Monate betrage. Auf die Verschriftlichung des Protokolls warte man weitere sechs bis sieben Monate. In diesem Protokoll würden Anforderungen an statistische Signifikanz und klinische Relevanz festgelegt. Hersteller stellten immer wieder fest, dass sich die Meinung des BfArM ändere, was das Verfahren intransparent mache. Sie erkennt an, dass das BfArM eine schwierige Aufgabe habe, da Deutschland das einzige Land mit dieser Gesetzgebung sei und die Gestaltung von Studien selbst in der Wissenschaft kritisch diskutiert werde. Sie wünsche sich ein stabileres Verfahren mit klareren Spielregeln. Von den 15 gestrichenen



Nur zur dienstlichen Verwendung

DiGA seien sechs auf Antrag der Hersteller gestrichen worden.

Abg. **Matthias Mieves** (SPD) teilt den Wunsch von Dr. Klaus Reinhardt, DiGA besser in bestehende Versorgungsprozesse und Strukturen zu integrieren. Er fragt, welche konkreten Vorschläge es gebe, um DiGA besser mit der Arbeit in Arztpraxen zu verknüpfen.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) antwortet, dies könne nur auf der Ebene der Hersteller und Entwickler geschehen, indem sie die Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten in der Realversorgung suchten. Er gehe davon aus, dass dies bereits geschehe, aber die Frage sei, wie viel mehr Nutzen DiGA im Verhältnis zu den herkömmlichen Behandlungsformen brächten und wie viel dies wert sei.

Abg. **Matthias Mieves** (SPD) fragt Dr. Michaela Eikermann, welche konkreten Vorschläge sie für ein angemessenes Evidenzniveau und mehr Stabilität bei den Zulassungskriterien habe.

Dr. Michaela Eikermann (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)) antwortet, die derzeitigen DiGA-Studien seien in der Regel randomisierte, kontrollierte Studien. Sie setze daher auf mehr Transparenz im Verfahren, damit für alle ersichtlich sei, was in den Studien gemacht werde, wie die Ergebnisse seien und diese Studien eingeordnet werden könnten.

10:47 Übergabe der Sitzungsleitung an die Vorsitzende

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt die BÄK nach den Gründen für die vermeintlich zurückhaltende Verschreibungspraxis von DiGA.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) entgegnet, er sei sich nicht sicher, ob dieser Vorwurf zutreffe. Er verweist auf eine Million DiGA-Anwendungen, die bis Ende 2024 verordnet worden seien. Er betont, dass die Inanspruchnahme im

Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent gestiegen sei und sich dynamisch entwickle. Insbesondere Hausärzte und Hausärztinnen sowie Psychotherapeuten verordneten einen Großteil der DiGA. Er führt aus, dass DiGA nicht für alle Fachgruppen gleichermaßen relevant seien. Sie kämen vor allem bei psychischen und Stoffwechselerkrankungen sowie bei Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems zum Einsatz. Er sei überzeugt, dass sie einen qualitativen Fortschritt darstellen könnten, insbesondere im Monitoring von Stoffwechselerkrankungen. Die Bundesärztekammer versuche, das Thema in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu verankern.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob es sich bei DiGA trotz der hohen Zahl um einen Nischenbereich handele.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) bejaht dies mit Blick auf die Versorgungsrelevanz. Er erklärt, dass in der ärztlichen Praxis DiGA eher selten verordnet würden, es sei denn, der Patient spreche das Thema an.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob eine 14-tägige Testphase für DiGA sinnvoll wäre.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) bejaht dies und sagt, dass die Bundesärztekammer dies als eingeschränkt sinnvoll erachte und deutlich unterstütze.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob das Problem in der fehlenden Integration in die Versorgungspfade und Abläufe liege, da die Anwendungen oft ein Inseldasein fristeten.

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) antwortet, dass beispielsweise DiGA für Stoffwechselerkrankungen EDV-technisch besser in die Dokumentation in der Arztpraxis integriert werden könnten, was sich positiv auf die Durchsetzung auswirken würde.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt den GKV-Spitzenverband nach notwendigen Veränderungen im Bereich der Preisverhandlungen.

Thorsten Busse (GKV-Spitzenverband) antwortet, dass die 40 verhandelten Preise deutlich unter den zuvor veranschlagten Herstellerpreisen lägen. Er wiederholt seinen Vorschlag für ein gesetzgeberisches Korrektiv spätestens ab dem 13. Monat. Zudem plädiert er dafür, die Selbstzahlerpreise als Kriterium zu streichen und sie stattdessen maximal durch die verhandelten Preise zu ersetzen. Er merkt an, dass die Selbstzahlerpreise, wie bei einer 2 000-Euro-DiGA, absurd seien, da eine solche Zahlungsbereitschaft nicht existiere.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) fragt den Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung nach der rechtlichen und wissenschaftlichen Grundlage für die Zulassung der DiGA, die zum Zeitpunkt der Markteinführung keinen wissenschaftlich fundierten Nutznachweis hätten erbringen können. Sie möchte wissen, welche Anforderungen an die Evidenz im Rahmen der vorläufigen Aufnahme erfüllt werden müssten und wie der Nutznachweis in der Erprobungsphase sichergestellt werde.

Anisa Idris (Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV)) führt aus, DiGA seien Medizinprodukte, die sicher sein müssten und einen Effekt nachweisen müssten. Der Nutzen bei DiGA sei ein relativer und ökonomischer Nutzen. In der Erprobungsphase werde in der Regel in randomisierten, kontrollierten Studien geprüft, ob eine Therapieoption besser sei als die bestehende Versorgung. Sie stellt klar, dass Patienten in der Erprobungsphase nicht mit nutzlosen Produkten versorgt würden, da diese Produkte ein CE-Kennzeichen hätten und für die jeweilige Krankheit gedacht und getestet seien. Sie plädiert dafür, bei Preisvergleichen faire Maßstäbe anzulegen und verweist darauf, dass die 2 000 Euro für eine Behandlung von Multipler Sklerose im Vergleich zu den Alternativen nicht teuer seien.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) fragt, warum DiGA mit hohem Risikopotenzial, also Klasse 2b, ohne ärztliche Kontrolle auf den Markt kämen, wenn es an Transparenz und fundierten Studien fehle.

Anisa Idris (SVDGV) antwortet, dass derzeit keine DiGA der Klasse 2b gelistet seien. Produkte der Klasse 2b könnten zudem nicht in der Erprobung getestet werden, sondern müssten den Nachweis vorab erbracht haben. Die ärztliche Einbindung sei bei jedem Produkt gesondert gesichert.

Abg. **Stella Merendino** (Die Linke) fragt die BÄK nach der ärztlichen Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die psychiatrische Versorgung.

Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)) erwidert, er glaube nicht, dass die Mehrzahl der DiGA eine substitutive Form von Therapieangebot bedeute, sondern ein additives Angebot, das zusätzlich zu dem, was aktuell geschehe, verwendet werden könne.

Tagesordnungspunkt 2

Fachgespräch: Notwendige Reformen zur Verbesserung der Versorgung von psychisch Kranken – Vorstellung der Ergebnisse des 2. Psychiatrie-Dialogs

Selbstbefassung S-21(14)11

Prof. Dr. Peter Brieger (Aktion Psychisch Kranke (APK))¹ führt aus, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland nur schwer zeitnahe und bedarfsgerechte Hilfe fänden, da es zu viele parallele Strukturen und Partialinteressen gebe. Er plädiere für eine grundlegende Neuausrichtung. Psychische Gesundheit müsse regional verankert werden, indem ambulante, aufsuchende, teilstationäre und stationäre Behandlung flexibel, niedrigschwellig und bei Bedarf auch zu Hause erfolge. Er verweise auf § 64b SGB V, der Modellprojekte ermögliche und dessen Überführung in die Regelversorgung gut evaluiert, kostenneutral und mit

¹ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)17



Nur zur dienstlichen Verwendung

steigender Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit verbunden sei. Er erachte einen klaren gesetzgeberischen Schritt zur Verbesserung der Versorgung für psychisch kranke Menschen als notwendig. Als zweiten Schritt sehe er die Reform der psychiatrischen Institutsambulanzen. Schwerkranke und chronisch kranke Patienten erhielten oft nicht die erforderliche Hilfe, da ambulante Psychotherapie nicht ausreiche. Eine dauerhafte, multiprofessionelle Behandlung, auch durch Hausbesuche, werde daher immer wichtiger, insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Die Ambulantisierung des Krankenhauses auch in der Psychiatrie sei ein wesentlicher Schritt für mehr Patientenorientierung, höhere Behandlungsqualität und effizienteren Ressourceneinsatz. Er verweise diesbezüglich auf Empfehlungen, die die Aktion Psychisch Kranke mit dem BMG erarbeitet und dem Parlament übermittelt habe.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) führt aus, die Pflege sei darauf ausgerichtet, Menschen, die kaum Zugang zu Therapie und Rehabilitation hätten, niederschwellig zu erreichen. Die Pflege sei recovery-orientiert, könne zeitintensiver unterstützen und den Transfer von Therapie in den Alltag begleiten. Er stimme den Handlungsempfehlungen aus dem Psychiatrie-Dialog zu. Bei der Diskussion zu Zwangsmaßnahmen müsse die Pflege einbezogen werden, da es nicht nur um das Ob, sondern auch um das Wie gehe. Bei der Erstellung eines bundesweiten Orientierungsleitfadens für Besuchskommissionen müsse pflegerische Expertise vertreten sein. Das persönliche Budget sei ein wesentliches Instrument für Partizipation und es brauche mehr Anstrengung, um es auch in Behandlung und Pflege einsetzen zu können. Seine Herzensangelegenheit sei die Sicherstellung von Anschlussangeboten. Nach Krisenbehandlungen werde oft keine Assistenz angeboten, was zu Wohnungsverlust und Forensifizierung führen könne. Als Querschnittsthema erachte er die Beteiligung von Erfahrungsexpertise und eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und der Selbsthilfe als essenziell für die Weiterentwicklung der psychiatrischen Landschaft.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) führt aus, die DGPPN habe

an allen Foren des Psychiatrie-Dialogs teilgenommen und schätze den strukturierten Austausch. Die DGPPN unterstütze die Handlungsempfehlungen, insbesondere die Stärkung der Patientenbeteiligung in der Klinik und an den Schnittstellen. Sie befürworte die Stärkung von Besuchskommissionen und das Monitoring von Zwangsmaßnahmen. Als Schwerpunkte nenne sie die Stärkung eines bundesweiten Zwangsregisters für alle Gesundheitseinrichtungen und die Einführung einer regionalen Pflichtversorgung, die über das SGB V hinaus auch die Eingliederungshilfe einbeziehe. Sie sehe weiteren Diskussionsbedarf bezüglich der personen-zentrierten und bedarfsgerechten Versorgung. Zudem empfehle sie dringend, die Globalbudgets und die Überführung des § 64b SGB V in die Regelversorgung erneut aufzugreifen. Diskussionsbedarf bestehe auch bei der Notfallversorgung und der ambulanten Zwangsbehandlung.

Dr. Andrea Benecke (Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)) führt aus, dass der steigende Versorgungsdruck im Gesundheitssystem auch Menschen mit psychischen Erkrankungen betreffe. Sie plädiere für nachhaltige Reformen und erachte die Ergebnisse der beiden Psychiatrie-Dialoge als wichtige Impulse, die aufgenommen werden sollten, insbesondere zur besseren Versorgung, Koordination und Partizipation. Sie sei der Ansicht, dass das diskutierte Primärarztsystem die Versorgung psychisch kranker Menschen erschweren würde, da es eine zusätzliche Hürde darstelle. Sie verweise auf die seit 2017 bestehende psychotherapeutische Sprechstunde, die gut geeignet sei, Patienten zu untersuchen und in die Versorgung zu lotsen. Ein Primärarztsystem würde hingegen Doppeltermine und höhere Kosten verursachen sowie die Versorgung verzögern. Da eine Psychotherapie ohnehin vorab genehmigt werden müsse, seien Parallelbehandlungen ausgeschlossen. Sie betont, dass es vielmehr schnellere Versorgungsmöglichkeiten durch eine Reform der Bedarfsplanung brauche, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie in ländlichen Gebieten. Deutschland müsse sich zur Finanzierung der Weiterbildung committen, um die Versorgung mittel- und langfristig aufrechtzuerhalten.

Dr. Elke Prestin (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit) führt aus, dass jährlich rund 28 Prozent der Erwachsenen von einer psychischen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Erkrankung betroffen seien, wobei 1 bis 2 Prozent schwer erkrankten. Diese Menschen hätten das Recht auf Wahrung ihrer Menschenwürde, auf Selbstbestimmtheit und Teilhabe, was noch nicht vollumfänglich gewährleistet sei. Sie skizzierte drei notwendige Entwicklungsbereiche, die auch im Psychiatrie-Dialog genannt worden seien. Erstens, die Erfassung und wissenschaftliche Auswertung aller Zwangsmaßnahmen auf Bundesebene sei notwendig, um die Prävention von Zwang zu verbessern. Zweitens, die Partizipation von Betroffenen sei essenziell, da ihr Erfahrungswissen für die Planung und Ausgestaltung von Hilfen von hohem Wert sei. Hierfür müsse eine entsprechende Infrastruktur und Finanzierung gewährleistet werden. Drittens, das hochgradig segregierte Versorgungssystem sei insbesondere für schwer psychisch kranke Menschen dysfunktional. Sie plädierte für ein Hilfesystem ohne Brüche, bei dem die Betroffenen eine feste Bezugsperson mit Lotsen- und Koordinierungsfunktion hätten. Die Hilfen müssten zudem auf das Lebensumfeld bezogen sein und die Förderung sozialer Teilhabe zum Ziel haben.

Abg. **Pascal Reddig** (CDU/CSU) fragt Dr. Andrea Benecke nach Möglichkeiten zur Verbesserung der sektorübergreifenden Versorgung, insbesondere des Übergangs von stationärer zu ambulanter Behandlung. Zudem bitte er um detailliertere Ausführungen zur Prävention, um Resilienz und Gesundheitskompetenz zu stärken.

Dr. Andrea Benecke (Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK)) antwortet, dass die sektorübergreifende Versorgung ein großes Problem darstelle. Man solle die Entlassung aus dem Krankenhaus oder der Psychiatrie als Kriterium für die Dringlichkeit der Vermittlung in das ambulante System nutzen. Eine Möglichkeit sei die Abschaffung des Konsiliarberichts für Psychotherapeuten in Fällen, in denen Patienten bereits aus dem ärztlichen System kämen oder aus dem Krankenhaus überwiesen würden. Dies spare Zeit und Ressourcen. Hinsichtlich der Prävention sei es wichtig, die Widerstandskräfte der Menschen von Beginn an zu stärken, beginnend mit den frühen Hilfen vor und nach der Geburt, über Kita und Schule bis hin zur Arbeitswelt. Es müssten Verhältnis- und Verhaltensprävention betrachtet werden, wie etwa Elternprogramme, präventive Angebote in Schulen,

Aufklärungskampagnen oder die Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz gerade im Hinblick auf soziale Medien und Künstliche Intelligenz (KI).

Abg. **Pascal Reddig** (CDU/CSU) fragt nach der Bedeutung der im Koalitionsvertrag vereinbarten wohnortnahen psychosomatischen Institutsambulanzen.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) bejaht die Notwendigkeit einer gemeindenahen und niedrigschwelligen Versorgung. Ein Teil dieser Versorgung könne durch psychosomatische Institutsambulanzen abgedeckt werden. Sie befürworte es, wenn sie in die regionale Pflichtversorgung eingebunden seien.

Abg. **Pascal Reddig** (CDU/CSU) fragt, ob eine Regelung im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren für das Krankenhausreformenpassungsgesetz sinnvoll wäre.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) antwortet, sie halte dies für möglich.

Abg. **Pascal Reddig** (CDU/CSU) bittet um konkrete Maßnahmen zur Bedarfsplanung, insbesondere für den ländlichen Raum.

Dr. Andrea Benecke (Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK)) betont die Notwendigkeit einer Reform der Bedarfsplanung, da die Wartezeiten auf dem Land unzumutbar lang seien. Es gelte, die Lebensverhältnisse in strukturschwachen ländlichen Gebieten auszugleichen. Die derzeitige Bedarfsplanung für Kinder und Jugendliche, die eine feste Quote von 20 Prozent der psychotherapeutischen Versorgung vorsehe, sei lediglich ein Anhängsel und müsse reformiert werden.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt Dr. Sylvia Claus, ob sie einen Zusammenhang zwischen der zunehmenden Digitalisierung und der Häufigkeit



Nur zur dienstlichen Verwendung

psychischer Erkrankungen insbesondere bei Jugendlichen gebe.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) antwortet, dass noch nicht viele Forschungsergebnisse vorlägen, aber die Nutzung digitaler Medien und insbesondere sozialer Medien bei Kindern und Jugendlichen einen Einfluss zu haben scheine und weiterer Forschungsbedarf bestehe.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, ob bereits ein Suchtverhalten festgestellt worden sei.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) führt aus, dass dies intensiv untersucht werde, aber noch keine abschließenden Belege für ein Suchtverhalten vorlägen.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) erkundigt sich nach gegenwärtigen Diskussionen über die Rückführung der Digitalisierung in Schulen wie in den nordischen Ländern.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) antwortet, dass Diskussionen über die sinnvolle Nutzung sozialer Medien und die Notwendigkeit von Zeitgrenzen sinnvoll seien, da Problematiken im Zusammenhang mit der Ausweitung sozialer Medien bestünden. Eindeutige Daten für massive Einschränkungen gebe es nicht, aber eine Einbindung in pädagogische Konzepte sei sinnvoll.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, ob ein Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Migration und der Häufigkeit psychischer Erkrankungen bestehe und ob Migrant*innen einen erhöhten Bedarf hätten.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) erklärt, dass keine Zunahme psychischer Erkrankungen bei Erwachsenen

zu verzeichnen sei. Bei Kindern und Jugendlichen träten jedoch insbesondere affektiven Störungen, die mit den Veränderungen durch die Corona-Pandemie zusammenhängen könnten, häufiger auf. Risikofaktoren für psychische Erkrankungen seien prekäre Verhältnisse, Arbeitslosigkeit und ein Migrationshintergrund, aber ein direkter Zusammenhang zwischen der Zunahme psychischer Erkrankungen und dem Anteil der Bürger mit Migrationshintergrund könne nicht hergestellt werden.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) thematisiert die Unterbringung von Schwerverbrechern in psychiatrischen Einrichtungen statt in Gefängnissen und fragt, ob diese Entscheidung richtig sei oder eine zusätzliche Belastung und Gefahr für das Personal darstelle.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) führt aus, dass das Rechtssystem gut zwischen schuldfähigen und vermindert schuldfähigen Personen unterscheide. Eine psychische Erkrankung könne zur verminderten Schuldfähigkeit führen. Der Zusammenhang zwischen Erkrankung und Tat werde in Maßregelvollzugseinrichtungen bearbeitet, wo gute Erfolge und Therapieprogramme existierten. Sie befürworte die Trennung und sehe nicht, dass eine Unterbringung in Haftanstalten die psychische Erkrankung verbessern oder sekundär präventiv wirken könne.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) wendet ein, dass dies mehr Personal binde und dessen Belastung erhöhe.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) erklärt, dass im SGB V-System die normale Krankenhausbehandlung für psychisch kranke Menschen vorgesehen sei. Im Maßregelvollzug sei die Ausstattung räumlich, personell und qualitativ so gestaltet, dass psychisch kranke Straftäter gut behandelt, Risiken reduziert und spezielle Deeskalationen durchgeführt werden könnten.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt nach der Entscheidungsfindung bei der kürzlich erfolgten Entlassung eines irakischen Straftäters aus der Psychiatrie gegen den ärztlichen Rat.

Dr. Sylvia Claus (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)) antwortet, dass sie zu diesem Einzelfall keine Auskunft geben könne, versichert aber, dass Entlassungsentscheidungen prinzipiell im multiprofessionellen Team getroffen und gut abgewogen würden.

Abg. **Stefan Schwartz** (SPD) bittet Dr. Andrea Benecke, ihre Einschätzung zum Primärarztssystem darzulegen.

Dr. Andrea Benecke (Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)) erläutert, dass das Primärarztssystem dazu dienen solle, Patienten mit fachspezifischem Behandlungsbedarf zunächst hausärztlich zu versorgen, bevor sie weiterüberwiesen würden. Sie gibt zu bedenken, dass psychische Erkrankungen nach wie vor stigmatisiert seien und Menschen oft lange bräuchten, um Hilfe zu suchen. Ein niedrigschwelliger Zugang sei daher essenziell. Die Notwendigkeit, zuerst einen Hausarzt aufzusuchen, könne eine Hürde darstellen, da viele Patienten keinen Hausarzt hätten oder sich scheuten, ihre psychischen Beschwerden anzusprechen. Das Argument, Doppeltermine oder -behandlungen durch das Primärarztssystem zu vermeiden, treffe auf die Psychotherapie nicht zu, da die Krankenkasse bei Beantragung einer Psychotherapie über bereits laufende Behandlungen informiert sei und eine zweite ablehne. Zudem könne eine abschließende Behandlung psychisch kranker Menschen beim Hausarzt oft nicht erfolgen, da nur sehr wenige Hausärzte eine fachgebundene psychotherapeutische Weiterbildung besäßen.

Abg. **Stefan Schwartz** (SPD) fragt Dr. Elke Prestin nach den Vor- und Nachteilen der Neufassung der „Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie“ (PPP-RL).

Dr. Elke Prestin (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit) betont die Relevanz der PPP-RL

aus Sicht der Betroffenen und befürwortet, dass genauer hingeschaut und Sanktionen bei mangelhafter Ausstattung in Betracht gezogen werden sollten. Eine gute Personalausstattung sei grundlegend für die Behandlungsqualität, da psychische Erkrankungen eine vertrauensvolle Beziehung erforderten. Obwohl Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung bestünden, plädiere sie dafür, diese Probleme zu lösen. Eine humane, menschliche und zugewandte Psychiatrie könne das Arbeitsfeld attraktiver machen und so mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen.

Abg. **Stefan Schwartz** (SPD) fragt Prof. Dr. Peter Brieger nach dessen Hauptforderungen zum Thema Weiter-, Fort- und Ausbildung.

Prof. Dr. Peter Brieger (Aktion Psychisch Kranke (APK)) hebt die Komplexität der Medizinstudiengplätze hervor. Es bestünden erhebliche Lücken im Psychotherapeutengesetz, insbesondere bei der Finanzierung der Psychotherapeuten in Kliniken. Er fordere daher Unterstützung, da das neue System nicht gut funktioniere. Auch die Weiterentwicklung der Pflege und multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Psychiatrie, die sich in entsprechenden Vorgaben widerspiegeln müsse, seien wichtig. Er weise darauf hin, dass die Abbildung dieser Ausbildungen in der PPP-RL teilweise zu absurden Situationen bei Prüfungen durch den medizinischen Dienst führe, indem beispielsweise Bewegungstherapeuten nicht eingesetzt und finanziert werden könnten, weil ihre Fachqualifikationen nicht anerkannt würden. Diese Dinge müssten auf praktischer Ebene geregelt werden.

Abg. **Stefan Schwartz** (SPD) fragt Thomas Buneta nach der Aus- und Weiterbildung in der Pflege.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrie (DFPP)) erklärt, dass die Pflege seit vielen Jahren einen Weg zur Akademisierung beschritten habe, viele Pflegefachleute hätten Bachelor- und Masterniveau sowie Professuren. Er verweise auf gute internationale Beispiele, was Pflegefachpersonen mit entsprechenden Kompetenzen, die er als Fähigkeiten und Befugnisse beschreibe, leisten könnten. Dazu gehöre sowohl das Wissen als auch das Tragen von Verantwortung.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonther** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt Prof. Dr. Peter Brieger nach weiteren konkreten Forderungen aus dem Psychiatrie-Dialog, insbesondere im Hinblick auf die Schnittstellen zu Teilhabe und Rehabilitation (Reha), die die bereits angesprochenen Themen Globalbudget, Zwangsreduktion durch Zwangsmonitoring und Stärkung der psychiatrischen Institutsambulanzen ergänzten.

Prof. Dr. Peter Brieger (Aktion Psychisch Kranke (APK)) betont, dass die im Psychiatrie-Dialog abgegebenen Empfehlungen, wie die Umsetzung eines Regionalbudgets, stärkere politische Unterstützung benötigten und eine gute Abstimmung mit den Ländern erforderten. An den Schnittstellen sei es komplex, aber eine Hilfeplanung, die die verschiedenen Aspekte und den Hilfebedarf im SGB IX sowie der Eingliederungshilfe berücksichtige, sei essenziell. Der Psychiatrie-Dialog habe hier Methoden und Entwicklungen aufgezeigt, die mit den anderen Fachministerien und Ländern zusammengeführt werden müssten.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonther** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet Dr. Andrea Benecke um konkrete Vorschläge zur Sicherung der Finanzierung der psychotherapeutischen Weiterbildung, da das Bundespsychotherapeutengesetz hier eine empfindliche Lücke aufweise.

Dr. Andrea Benecke (Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK)) führt aus, dass medizinische Versorgungszentren als Weiterbildungsstätten eine finanzielle Förderung benötigten, da ihre Einnahmen die Ausgaben für adäquate Gehälter nicht deckten. Hierfür solle § 75a SGB V geändert werden. Bei Weiterbildungsambulanzen, die direkt mit den Krankenkassen verhandelten, müssten § 117 und § 120 SGB V angepasst werden, um alle Leistungen, die über die Weiterbildung zu leisten seien, zu verhandeln. Im stationären Bereich seien zusätzliche Stellen erforderlich, da die derzeitigen Planstellen noch durch Pädagogen und Psychologinnen in Ausbildung besetzt seien, was sich jedoch bald ändern werde.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonther** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet Dr. Elke Prestin um eine

Beurteilung der aktuellen Einbeziehung von Betroffenen und Vorschläge zur Verbesserung.

Dr. Elke Prestin (Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit) antwortet, dass Partizipation sehr unterschiedlich ausgestaltet und stark ausbaufähig sei. Der Psychiatrie-Dialog und die Überarbeitung der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien seien positive Ausnahmen. Oft gebe es keine oder nur pro forma Partizipation, was schade sei, da Partizipation in mehrfacher Hinsicht wirke. Sie stärke die Betroffenen und liefere wichtigen Input für passgenaue Hilfen, Erfahrungen, Erlebensweisen, Bedarfe für Forschungsfragen und Feldkompetenz. Eine Planung und Evaluation ohne die Einbindung der Betroffenen sei unsinnig.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt Thomas Buneta, wie er einen Anspruch auf Case Management bei komplexem Versorgungsbedarf bewerte und welche Rolle die psychiatrische Pflege dabei spielen könne.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) stimmt zu, dass die Versorgung psychisch kranker Menschen zersplittert wirke. Der komplexe Hilfebedarf erfordere Hilfen aus verschiedenen Sozialgesetzbüchern, die klug zusammengeführt werden sollten. Ein Anspruch auf Case Management wäre ein wichtiger Schritt, um das Silo-Denken aufzuweichen. Die psychiatrische Pflege könne hierbei eine zentrale Rolle spielen, wie das Konzept der Community Mental Health Nurse zeige, indem Pflegekräfte gemeinsam mit den Erkrankten und ihren Angehörigen Wege aus der Krise entwickelten und umsetzten.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt nach dem Einfluss von Personalbemessung und Personalmangel auf die Häufigkeit und Qualität von Zwangsmaßnahmen.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) erklärt, dass eine schlechtere Qualität und eine schlechte Besetzung des Pflegefachpersonals zu häufigeren, schlechteren und gefährlicheren Zwangsmaßnahmen führten. Die Studienlage sei hier eindeutig. Es gehe um die



Nur zur dienstlichen Verwendung

Einhaltung der Menschenrechte, wofür gute und ausreichende Pflege erforderlich sei.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) erkundigt sich nach den Hintergründen der Empfehlung des Psychiatrie-Dialogs zur Ausweitung der Soziotherapie und der Rolle der psychiatrischen Pflege.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) führt aus, dass Vernetzung, Verlässlichkeit, Kooperation und Kontinuität erklärte Ziele des Psychiatrie-Dialogs und Kernaufgaben der Soziotherapie seien. Es bedürfe einer Vertrauensperson und Hilfen aus einer Hand, die so nah wie möglich an der Lebenswelt orientiert sein sollten. Die Expertise der Pflege sei prädestiniert, eine große Wirkung zu erzeugen, da Pflege in Behandlung, Reha, sozialer Teilhabe und der Pflegeversicherung stattfinde.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) fragt nach den konkreten Auswirkungen der diskutierten Kompetenzausweitung in der Pflege auf die psychiatrische Versorgung.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) wiederholt, dass Kompetenzen Fähigkeiten und Befugnisse seien, die bestimmte Bildungsvoraussetzungen und gut definierte Aufgabenzuweisungen erforderten. Er verweise auf internationale Vorbilder, bei denen Pflegefachpersonen komplexe Fallsteuerungen übernahmen, in Clearingstellen und die Ersteinschätzung eingebunden seien und niedrigschwellige Psychotherapie und Präventionsmaßnahmen durchführten. Eine Erweiterung pflegerischer Kompetenzen würde die Versorgung erheblich verbessern, da die Pflege niedrigschwellige, lebensweltorientierte, aufsuchende und zeitintensive Hilfen anbiete und auf die Förderung der Selbstständigkeit im Alltag und die Durchführung von Lebensaktivitäten abziele.

Abg. **Evelyn Schötz** (Die Linke) erkundigt sich zu Maßnahmen zur Verringerung der Zahl und der Eingriffstiefe von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie und zur Herstellung von mehr Transparenz.

Thomas Buneta (Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)) betont die Notwendigkeit der Bewusstseinsbildung und eines Zwangsregisters zur Erfassung und Überprüfung. Wesentlich sei das Handeln im Vorfeld, um Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Dazu gehörten entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Einbeziehung der Expertise von Betroffenen, beispielsweise durch Genesungsbegleitung. Er weise darauf hin, dass dies ein wichtiges Thema sei, das mehr Zeit zur Vertiefung benötige.

Tagesordnungspunkt 3

a) Bericht Bundesrechnungshof nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages: Entwicklung der Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung

Selbstbefassung S-21(14)17

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) führt aus, dass die Situation der GKV-Finzen mehr als besorgniserregend sei, was nicht allein auf die Ausgabensteigerungen des letzten Jahres zurückzuführen sei. Es sei der höchste Anstieg in den letzten 30 Jahren bei allen großen Ausgabeblocken wie Krankenhausversorgung, vertragsärztliche Versorgung und Arzneimittelausgaben zu verzeichnen. Das Problem sei, dass die Einnahmen nicht im gleichen Maße gestiegen seien, was zu einer kontinuierlich wachsenden Unterdeckung der GKV-Finzen geführt habe. Er verweise auf eine Studie der Uni Duisburg-Essen, die für den Zeitraum 1995 bis 2021 ein Einnahmenwachstum von 50 Prozent gegenüber einem Ausgabenwachstum von 82 Prozent festgestellt habe. Vor Corona sei dies aufgrund hoher Rücklagen der Krankenkassen weniger problematisch gewesen, doch diese seien durch Finanzspritzen und einmalige Maßnahmen wie Bundeszuschüsse, Vermögensabgaben und Darlehen aufgebraucht worden. Damit habe man jedoch keine strukturellen Veränderungen bewirkt, sondern lediglich Zeit erkaufte. Eine Prognose des BMG aus dem Frühjahr schätze das jährliche Wachstum der Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben auf 6 bis 8 Milliarden Euro, was einen Anstieg des Zusatzbeitragssatzes um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr bedeute. Dies würde bis 2029 einen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 4,05 Prozent (aktuell 2,5 Prozent) ergeben. Er befürworte das Bekenntnis der Koalition zur Stabilisierung der GKV-Finzen,



Nur zur dienstlichen Verwendung

kritisiere jedoch, dass die Zeit für das Abwarten von Ergebnissen einer Expertenkommission fehle, da die Lücke jedes Jahr weiterwachse. Es seien weitreichende Strukturreformen erforderlich, die sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite umfassend in den Blick nehmen und zeitnah umgesetzt werden müssten, wobei die Krankenhausreform zwar ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber allein nicht ausreiche.

b) Bericht der Bundesregierung zum Bericht des Bundesrechnungshofes

Selbstbefassung S-21(14)16

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) schließt sich den Ausführungen des Bundesrechnungshofs an und betont, dass BMG und BRH unterschiedliche Aufgabenstellungen verfolgten. Er unterstreicht die Wichtigkeit der finanztechnischen und bilanziellen Feststellungen des BRH, die ein länger angelegtes Problem beleuchteten, welches durch Einmalfaktoren wie die Corona-Pandemie und den demografischen Wandel verstärkt werde. Das BMG fühle sich der Beitragsstabilität verpflichtet, auch wenn diese in Bürgerumfragen manchmal nicht an erster Stelle stehe. Die Beitragsstabilität sei ein wirtschaftspolitisch hochrelevanter Faktor, und eine weitere Beitragsbelastung sei für die Bevölkerung unzumutbar. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Stabilisierung der Beiträge mit strukturellen Maßnahmen gelingen könne. Gleichzeitig seien Sofortmaßnahmen erforderlich, wozu der fortlaufende Prozess der Krankenhausreform gehöre, der nun vollendet werden müsse. Um zu vermeiden, dass Krankenhäuser aufgrund finanzieller Engpässe in dieser Übergangsphase schließen müssten, sei der Soforttransformationsfonds eingerichtet worden. Dieser sei keine Gießkannenmethode, es seien aber mit vertretbarem bürokratischem Aufwand keine zielgenaueren Zahlungen möglich. Ein wesentlicher Punkt sei die selbstkritische Erkenntnis, dass das Gesundheitssystem nicht nach dem Motto „viel hilft viel“ funktioniere. Bei einem Finanzvolumen von 500 Milliarden Euro sei man trotz signifikanter Ausgaben nicht mit den Ergebnissen zufrieden. Die Überlebensraten und Erfolgsquoten bei bestimmten Behandlungsverläufen entsprächen nicht den Erwartungen. Daher sei es im Rahmen des Strukturprozesses wichtig, das Verhältnis der Leistungsausgaben zu den tatsächlich eingetretenen

Behandlungserfolgen kritisch zu überprüfen, um Effizienz und Qualität zu steigern. Er widerspricht der Annahme, dies käme Leistungskürzungen gleich. Leistungskürzungen reduzierten berechnete Leistungen unberechtigterweise. Wenn jedoch eine Leistung den Erfolg verfehle und daher auf das geeignete Maß konzentriert werde, handele es sich um eine Leistungskonzentration.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) betont, dass die Politik mutige Entscheidungen benötige, da kein Erkenntnisproblem bestehe. Sie fragt, wie die geplante Einführung eines Primärversorgungssystems im Kontext der im Bericht angemahnten Strukturreformen bewertet werde.

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) entgegnet, dass er das Primärversorgungssystem für eine sehr sinnvolle Maßnahme halte, die zu Kosteneinsparungen führen könne, wenn Patienten zunächst beim Hausarzt vorstellig würden. Wichtig sei hierbei eine ausreichend große hausärztliche Versorgung. Er sehe ein großes Einsparpotenzial bei der Notfallreform, insbesondere wenn Patientenströme zwischen stationärer und ambulanter Versorgung besser gelenkt würden. Sachverständige gingen von Einsparungen von 3 bis 5 Milliarden Euro jährlich aus, was etwa 30 Millionen Krankenhaustagen entspreche.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) fragt die Bundesregierung, inwieweit das Ziel der Auffüllung der Finanzreserven der Krankenkassen mit der letzten Beitragssatzanhebung im ersten Halbjahr erreicht werde und ob es Unterschiede zwischen den Kassenarten gebe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass die Überlegung der Rücklagenauffüllung unverändert aktuell und strukturell sehr wichtig sei, aber in Abhängigkeit von den Patienten Klientelen der Krankenkassen von unterschiedlichem Erfolg gekrönt werde. Die Rücklagenauffüllung sei vonnöten, um kurzfristige Zahlungsprobleme und damit verbundene Zusatzbeitragserhöhungen zu vermeiden. Die permanente Abpufferung durch Rücklagen sei ein wichtiges Instrument, das in der Vergangenheit zu kurz gekommen sei. Er sehe einen geringen Dissens zum



Nur zur dienstlichen Verwendung

Bundesrechnungshof hinsichtlich der Spanne der Rücklagen, wobei er eine Spanne von 0,2 bis 0,5 als ausreichend ansehe, um auf unterjährig auf veränderte Einnahme- und Ausgabensituation reagieren zu können.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) fragt den Bundesrechnungshof, welche konkreten Instrumente aus dem Gutachten des Sachverständigenrats für Gesundheit im Arzneimittelbereich als umsetzungswürdig und besonders erfolgreich angesehen würden.

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) führt aus, dass es bei den Generika keine Einsparpotenziale gebe, da diese durch Rabattverträge bereits ausgeschöpft seien. Man müsse sich stattdessen den hochpreisigen, verschreibungspflichtigen Medikamenten widmen. Der Sachverständigenrat weise darauf hin, dass deren Preise an den patientenrelevanten Mehrwert gekoppelt werden könnten, denn diese Arzneimittel seien die Kostentreiber.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) erkundigt sich beim BMG, ob angesichts der in den letzten Jahren gestiegenen Ausgaben für präventive Leistungen Einsparungen geplant seien und ob dies auch Kuren oder Reha betreffe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass Prävention eine große Priorität habe, da ein investierter Euro vier Euro Einsparungen erziele.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) fragt, ob der Ausgleich der Beitragsüberweisungen für Bürgergeldempfänger durch den Bund, der für 2025 nicht erfolge, auch für 2026 keine Rolle spiele und wie sich die Leistungsausgaben pro Kopf bei Bürgergeldempfängern im Vergleich zu anderen Beitragszahlern verhielten.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass die Absicht der Bundesgesundheitsministerin, versicherungsfremde Leistungen in der GKV stärker aus Steuermitteln zu finanzieren, im Rahmen der

Ressortabstimmung im Kabinett noch nicht habe geeint werden können. Man arbeite an diesem Thema, da es sich um einen Systemfehler handle, der die GKV zu Unrecht belaste. Zu den genauen Zahlen könne er keine Aussage machen, da die amtlichen Statistiken der GKV auf der Ausgaben-seite keine Differenzierung nach Beitragszahlungsarten vornähmen, sondern nach Leistungserbringern und Leistungen unterschieden.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) fragt, ob im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen eine Strukturreform geplant sei, da die 90 Kassen einen großen Verwaltungsaufwand mit Vorständen und Regionalvorständen hätten und durch den Gesundheitsfonds die Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Konkurrenzsituation gering geworden seien.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, er bekenne sich zur Selbstverwaltung und Eigenständigkeit der Krankenkassen. Eine Reduzierung der Krankenkassen würde lediglich zu einem Einmaleffekt führen. Zwischen den einzelnen Krankenkassen gebe es signifikante Unterschiede und einen echten Wettbewerb, insbesondere bei Zusatz- und Beratungsleistungen sowie im Bereich der Digitalisierung. Auch die verschiedenen Arbeitsweisen, etwa beim Erkenntnisgewinn für neue Ausschreibungsverfahren bei Rabattverträgen, seien zielführend und nützlich. Die Frage, ob Krankenkassen am Markt bestehen könnten, sei ein normaler wettbewerblicher Vorgang, und der Gesetzgeber habe nicht die Absicht, hier einzugreifen.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) fragt nach den zusätzlichen Investitions- und Implementierungskosten, mit denen das Ministerium kurzfristig bei der Umsetzung diverser Reformen wie der Krankenhaus-, Notfall- und Digitalisierungsreform sowie des Gesundheitsdaten-Nutzungsgesetzes rechne, und welche Einsparungen mittelfristig erwartet würden.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass bei maximaler Digitalisierung ein Einsparvolumen von 40 Milliarden Euro erwartet werde.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) dankt dem BRH für den Bericht, der die GKV-Financen unter massiven Druck zeige, während die Versicherten bereits mit Beitragssteigerungen in Vorleistung getreten seien. Er fragt das BMG nach kurzfristigen Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Beitragssteigerungen zum Jahreswechsel.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass kurzfristige Maßnahmen innerhalb weniger Wochen, die ein Defizit von 4 bis 8 Milliarden Euro abdecken könnten, illusorisch seien. Solche Summen könnten nur durch außerplanmäßige Subventionen, wie Darlehen, aufgebracht werden. Dies bedeute jedoch, dass die weiteren Analyseprozesse mit umso größerer Intensität vorangetrieben werden müssten. Obwohl der Koalitionsvertrag von 2027 spreche, gehe man zuversichtlich davon aus, dass durch die Bündelung der Analyse- und Beratungsarbeit bereits Anfang 2026 Strukturmaßnahmen beschlossen werden könnten, die zum 1. Januar 2027 zu einer deutlichen Entlastung führen würden.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) fragt nach der Krankenhausreform, da der Bundesrechnungshof wirksame Strukturreformen fordere, aber auch Befürchtungen bestünden, dass die Krankenhausreform verwässert werde und die notwendigen Einsparungen nicht erzielt würden.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, er teile diese Befürchtungen nicht und sehe keinen konkreten Ansatz für eine Verwässerung. Er glaube, dass eine Konzentration, die naturgemäß mit einer Reduzierung von Häusern und Betten einhergehe, zu einer Qualitätssteigerung und Qualitätsverbesserung führen werde. Eine bessere Lenkung der Patienten, zum Beispiel in den ambulanten Versorgungsbereich, sei ebenfalls erwartbar. Dies sei jedoch kein Prozess, der durch Umlegen eines Schalters zu bewerkstelligen sei, sondern erfordere einen Konsens, um die Veränderungen zügig umzusetzen und diese den Patienten zu kommunizieren. Der Wegfall von Grundversorgungshäusern in unmittelbarer Nähe stelle kein Versorgungsdefizit dar. Dazu gehöre auch die Reform des Notfallwesens, die vermeintliche Abstände kompensieren werde. Er sei

sich sicher, dass dies gelingen werde, und halte geringfügige Verlängerungen von Übergangsfristen im Gesetzentwurf für vertretbar. Positive Initiativen zur zügigeren Umsetzung würden keinesfalls unterbunden.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont die dramatische Finanzlage der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Er weise darauf hin, dass die Beiträge stark gestiegen seien und über 20 Krankenkassen bereits unterjährig ihren Zusatzbeitrag hätten erhöhen müssen. Er fragt den Bundesrechnungshof, wie er bewerte, dass man Darlehenskonstrukte bevorzuge, anstatt versicherungsfremde Leistungen direkt auszugleichen oder Strukturreformen umgehend auf den Weg zu bringen. Der Bund zahle pro Bürgergeldbeziehendem lediglich 133 Euro, während die tatsächlichen Kosten 350 Euro betrügen, decke somit nur 39 Prozent der Kosten ab. Das Delta gehe zulasten der Versichertengemeinschaft.

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) antwortet, dass Darlehen keine strukturellen Probleme lösten, sondern lediglich teuer erkaufte Zeit darstellten und bei der Rückführung zusätzliche Probleme schufen. Die Situation werde sich bis dahin nicht verbessert haben. Hinsichtlich der versicherungsfremden Leistungen gebe es keine Legaldefinition. § 221 SGB V gewähre eine pauschale Abgeltung durch den Bund in Höhe von 14,5 Milliarden Euro, deren Höhe in der Vergangenheit je nach Kassensituation variiert habe. Eine spezifische Prüfung zu Bürgergeldempfängern sei nicht durchgeführt worden. Eine Erhöhung der Sätze sei eine politische Entscheidung.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, inwieweit es sachgerecht sei, 4 Milliarden Euro rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023 als Inflationskostenausgleich unter dem Label „Soforttransformation“ nach dem vorgeschlagenen Verfahren an die Krankenhäuser auszuschütten und ob die Krankenhausfinanzierung für die aktuellen Aufgaben der GKV-Ausgabenrelevanz habe.

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) führt aus, dass der Bundesrechnungshof erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel an der



Nur zur dienstlichen Verwendung

Sachgerechtigkeit dieser Maßnahme hege, da es sich um eine Förderung mit der Gießkanne handle, die nichts mit Investitionen zu tun habe. Er rate dazu, dies verfassungsrechtlich zu prüfen. Zudem sei die Maßnahme nicht wirtschaftlich, da sie Krankenhäuser, insbesondere große Träger, dazu verleiten könne, die Mengen auszuweiten, wie in der Vergangenheit bei Freihaltepauschalen beobachtet worden sei. Diese Gefahr bestehe bei großen Krankenhauskonzernen. Die Krankenhäuser seien mit einer Milliarde Euro pro Tag der größte Kostenblock bei den GKV-Ausgaben.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, ob es vor diesem Hintergrund sachgerecht sei, eine Reform der Krankenhausreform anzustreben, die den notwendigen Konzentrationsprozess verschiebe, Qualitätsstandards senke und Ausnahmen erweitere, und ob dies negative Effekte für die Ausgabenentwicklung haben könne.

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) bejaht diese Gefahr und verweist auf die Einzelplananalyse. Es sollten keine Maßnahmen im Rahmen des Krankenhausanpassungsgesetzes ergriffen werden, die die Ziele der Krankenhausreform tangieren könnten. Ausnahmeregelungen für Leistungsgruppen trotz Nichterfüllung der Qualitätskriterien und die Vorhaltefinanzierung auf Basis von Ist- statt Planungsfallzahlen könnten diese Zielsetzung gefährden.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) fragt nach Maßnahmen bis zum Jahresende, um die Beitragssteigerungen zu verhindern.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass die derzeitigen Überlegungen und Diskussionen über die Wirksamkeit der angedachten Maßnahmen noch nicht abgeschlossen seien. Man warte auf die Aussagen des Schätzerkreises im Oktober. Er weise darauf hin, dass die Problemstellungen erst Mitte des Jahres in die Überlegungen einbezogen worden seien und nur ein Zeitfenster von etwa sechs Monaten zur

Lösung bestehe. Derzeit diskutiere man mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF), inwieweit kurzfristig weitere Steuergelder zur Sicherstellung der Beitragsstabilität eingesetzt werden könnten.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) fragt den BRH nach den Berechnungen zu Einsparpotenzialen aus der Krankenhausreform, Notfallreform und der Digitalisierung. Das BMG nenne etwa 40 Milliarden Euro Einsparpotenzial durch die Digitalisierung und der BRH nenne 4 bis 5 Milliarden Euro jährlich bei der Notfallreform. Er bittet um schriftliche Mitteilung der Zahlen.²

Oliver Sievers (Bundesrechnungshof (BRH)) erklärt, dass der Bundesrechnungshof dies nicht geprüft habe und lediglich Zahlen aus der Fachwelt zusammentragen könne.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) betont, dass zwar zuverlässige Prognosegrundlagen wünschenswert seien, dies aber das Kernproblem darstelle. Die Beschreibungen des Einsparpotenzials durch die Digitalisierung sei eine Schätzung, die auf Hypothesen beruhe. Er halte es für wirkungsvoller, sich auf kurzfristig und mit überschaubarem Effekt anwendbare Maßnahmen zu konzentrieren, wie die Berechnungen im Rahmen des Rettungs- und Notfallwesens, da dort die Kosten und Fehlleistungen im System genau bekannt seien. Das Gesamteinsparpotenzial einer umfassenden Krankenhausreform zu schätzen, sei nicht ohne Weiteres möglich.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) führt aus, dass es zwar nachvollziehbar sei, nicht jeden Digitalisierungseffekt exakt berechnen zu können. Es existierten jedoch für alle diskutierten Möglichkeiten wie Digitalisierung, Entökonomisierung, Krankenhausreform und Notfallreform Begrifflichkeiten, die Kostensenkungen versprächen, während rückblickend oft Kosten entstünden. Er erbitte vom BMG daher eine konkrete Zahl zu den erwarteten Einsparungen. Des Weiteren schließe er sich den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes zur Problematik

² Anlagen: Ausschussdrucksachen 21(14)19 und 21(14)32



Nur zur dienstlichen Verwendung

des Gießkannenprinzips bei der Ausschüttung von Geldern an Krankenhäuser für die Jahre 2022 und 2023 an und fragt, ob es nach den Ausführungen von Herrn Sievers neue Überlegungen gebe, wie die Gelder verteilt werden könnten.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, dass der Hinweis auf das Gießkannenprinzip sehr ernst genommen werde und sachlich entgegengewirkt werden solle. Er betone jedoch, dass ohne entsprechende Finanzunterstützung Krankenhäuser unplanmäßig geschlossen würden, und dieser Effekt so weit wie möglich verhindert werden müsse.

Tagesordnungspunkt 14

Nachbericht zur Sitzung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) (Formation Gesundheit) am 20. Juni 2025 in Luxemburg

Selbstbefassung S-21(14)12

abgesetzt

Schluss der Sitzung: 12:27 Uhr

Dr. Tanja Machalet, MdB
Vorsitzende

Dr. Stephan Pilsinger, MdB
Stellvertretender Vorsitzender